

1. Introducción y relevancia clínica

Las **urgencias oftalmológicas** constituyen un grupo de condiciones que amenazan la **integridad estructural o funcional del ojo**, y que, si no se tratan de manera inmediata, pueden causar **pérdida visual irreversible o incluso pérdida del globo ocular**.

Aunque muchas son de manejo especializado, el **médico general o de urgencia** debe reconocerlas precozmente, iniciar medidas básicas y **derivar de forma oportuna al oftalmólogo**.

En el contexto del **EUNACOM**, los escenarios clínicos de ojo rojo doloroso, pérdida súbita de visión, trauma ocular y exposición a agentes químicos son **preguntas recurrentes**, porque reflejan competencias esenciales en el abordaje inicial del paciente crítico oftalmológico.

Las principales urgencias oftalmológicas incluyen:

- **Glaucoma agudo de ángulo cerrado**
- **Uveítis anterior aguda**
- **Queratitis infecciosa o ulcerativa**
- **Traumatismos oculares (contusos, penetrantes, químicos)**
- **Desprendimiento de retina**
- **Oclusiones vasculares retinianas**
- **Endoftalmitis postquirúrgica o postraumática**

El objetivo de este capítulo es entregar un enfoque práctico, fisiopatológico y clínico que permita **identificar, estabilizar y derivar correctamente** estos cuadros.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismos de daño ocular agudo

Las urgencias oftalmológicas suelen derivar de cuatro mecanismos fisiopatológicos principales:

Mecanismo	Ejemplo clínico	Consecuencia principal
Aumento súbito de presión intraocular (PIO)	Glaucoma agudo de ángulo cerrado	Isquemia del nervio óptico
Inflamación intraocular severa	Uveítis, endoftalmitis	Opacificación de medios ópticos
Compromiso corneal o epitelial	Queratitis, úlcera corneal	Pérdida de transparencia corneal
Trauma mecánico o químico	Heridas, quemaduras	Perforación, necrosis o cicatrización opaca
Alteración de perfusión retiniana	Oclusión arterial/venosa	Infarto retiniano, pérdida visual súbita

2.2 Anatomía funcional y vulnerabilidad ocular

El globo ocular presenta estructuras especializadas pero altamente sensibles:

- **Córnea:** carece de vasos, pero está densamente innervada (dolor intenso ante daño).
- **Cámara anterior:** cambios bruscos de presión afectan el flujo de humor acuoso.
- **Retina y nervio óptico:** extremadamente vulnerables a hipoxia y cambios vasculares.
- **Estructuras anexas (párpados, conjuntiva):** protegen el ojo, pero son puntos de entrada a infecciones.

Por tanto, el **dolor ocular agudo, la visión borrosa o la fotofobia** son señales de alarma que requieren evaluación inmediata.

2.3 Conceptos fisiopatológicos clave

1. Presión intraocular (PIO):

- Normal: 10–20 mmHg.
- En glaucoma agudo, puede superar 40–60 mmHg → daño rápido del nervio óptico.

2. Inflamación ocular:

- En uveítis o endoftalmitis, el aumento de células y proteínas en el humor acuoso reduce su transparencia (“flare y cells”).

3. Perfusión retiniana:

- La retina depende de flujo constante; una oclusión arterial de minutos causa necrosis irreversible.

4. Integridad corneal:

- La pérdida epitelial (úlceras, quemaduras) permite infección y cicatrización con pérdida de visión.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Presentación clínica según urgencia

Urgencia	Síntomas principales	Signos distintivos	Diagnóstico diferencial
Glaucoma agudo de ángulo cerrado	Dolor ocular intenso, visión borrosa, halos de colores, cefalea, náuseas	Midriasis media fija, córnea opaca, PIO elevada	Uveítis, queratitis
Uveítis anterior aguda	Dolor ocular, fotofobia, ojo rojo	Miosis, precipitados queráticos, flare en cámara anterior	Glaucoma, queratitis

Queratitis infecciosa / úlcera corneal	Dolor, lagrimeo, fotofobia	Lesión corneal con tinción fluoresceína positiva, inyección ciliar	Conjuntivitis, cuerpo extraño
Desprendimiento de retina	Fotopsias, “moscas volantes”, cortina negra	Retina desprendida y móvil al FO	Oclusión vascular, hemorragia vítrea
Oclusión de arteria central de la retina (OACR)	Pérdida visual súbita, indolora	Retina pálida con fovea roja (“mancha rojo cereza”)	Neuritis óptica, isquemia
Oclusión venosa retiniana (OVCR)	Pérdida visual subaguda	“Tortuosidad venosa + hemorragias en llama”	Retinopatía diabética
Trauma químico ocular	Dolor severo, blefaroespasma, visión borrosa	Córnea blanquecina o necrótica	Cuerpo extraño, úlcera
Endoftalmitis	Dolor, edema palpebral, pérdida rápida de visión	Hipopion, secreción purulenta, FO velado	Uveítis, absceso orbitario

3.2 Diagnóstico diferencial de ojo rojo doloroso

Etiología	Características clínicas	PIO	Reflejo pupilar
Conjuntivitis	Picazón, secreción, sin visión afectada	Normal	Normal

Uveítis anterior	Dolor, fotofobia, miosis	Normal o baja	Disminuido
Glaucoma agudo	Dolor severo, visión borrosa, halos	Elevada	Pupila media fija
Queratitis	Dolor, fotofobia, lagrimeo	Normal	Reflejo abolido por dolor

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Examen ocular básico de urgencia

1. **Agudeza visual:** con cartilla o lectura de objetos.
 2. **Pupilas:** buscar anisocoria, midriasis fija, o Marcus Gunn.
 3. **PIO:** estimar con tonometría o palpación digital comparativa.
 4. **Biomicroscopía (si disponible):** detección de células en cámara anterior o lesiones corneales.
 5. **Tinción con fluoresceína:** revela úlceras o abrasiones.
 6. **Oftalmoscopía directa:** permite identificar desprendimiento, papiledema o hemorragias.
-

4.2 Criterios de derivación urgente

Derivar **inmediatamente** a oftalmología ante:

- Pérdida visual súbita, dolor ocular intenso o halos de colores.
- Trauma ocular penetrante o químico.
- Ojo rojo con miosis y fotofobia (uveítis).

- Presencia de hipopion o secreción purulenta intraocular.
 - Edema de papila o hemorragia retiniana extensa.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Medidas generales

- Evaluar **signos vitales y compromiso sistémico**.
 - Suspender lentes de contacto.
 - **No aplicar corticoides tópicos sin diagnóstico**.
 - Indicar **analgesia sistémica y reposo visual**.
 - Proteger el ojo con **escudo ocular rígido** (no parche).
-

5.2 Manejo inicial según diagnóstico presuntivo

Urgencia	Medidas inmediatas	Derivación
Glaucoma agudo	Acetazolamida 500 mg EV o VO + timolol 0,5% + pilocarpina (una vez reducida la PIO) + manitol EV si no responde	Urgente a oftalmología para iridotomía
Uveítis anterior	Midriáticos (ciclopentolato), corticoides tópicos (si indicados por especialista)	Derivación preferente
Queratitis / úlcera corneal	Antibióticos tópicos de amplio espectro (ciprofloxacino 0,3% cada 2 h)	Urgente
Desprendimiento de retina	Reposo absoluto, posición con cabeza hacia el lado de la lesión	Urgente

OACR	Masaje ocular + acetazolamida + bajar PIO (si <2 h de evolución)	Derivación inmediata
Trauma químico	Irrigar con suero fisiológico abundante (mínimo 30 min) + medir pH + analgesia	Urgente
Endoftalmitis	Inyecciones intravítreas antibióticas y corticoides sistémicos	Hospitalización inmediata

6. Complicaciones y pronóstico

Urgencia	Complicación principal	Pronóstico
Glaucoma agudo	Atrofia del nervio óptico	Irreversible si no se trata en horas
Uveítis	Sinequias, glaucoma secundario	Bueno si se trata precozmente
Queratitis	Úlcera corneal, perforación	Riesgo de pérdida de visión
Oclusión arterial retiniana	Infarto retiniano	Pérdida visual permanente
Desprendimiento de retina	Degeneración macular, ceguera	Variable según tiempo
Trauma químico	Necrosis corneal, simbléfaron	Secuelas graves
Endoftalmitis	Pérdida completa del ojo	Muy grave

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Dolor ocular + visión borrosa + halos de colores = glaucoma agudo hasta demostrar lo contrario.**
2. **El pH ocular debe normalizarse antes de detener la irrigación en quemaduras químicas.**
3. **Nunca usar parches en úlceras corneales o trauma penetrante.**
4. **La ausencia de dolor en lesiones graves puede indicar neuropatía (diabéticos).**
5. **Pupila media fija + córnea opaca + PIO elevada → diagnóstico clínico de glaucoma agudo.**
6. **La pérdida visual indolora súbita = urgencia vascular (OACR/OVCR).**
7. **No aplicar colirios corticoides sin diagnóstico definitivo.**

Errores comunes

- No medir la agudeza visual inicial (dato legal y diagnóstico).
- Parche ocular en úlcera o trauma → favorece infección.
- No irrigar de inmediato en exposición química.
- Atribuir ojo rojo con dolor a “conjuntivitis” sin descartar glaucoma o uveítis.
- No derivar urgencias visuales en menos de 24 h.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **urgencias oftalmológicas** pueden causar pérdida visual irreversible en horas; el reconocimiento precoz es fundamental.

2. **Dolor ocular intenso + disminución visual + ojo rojo profundo** sugiere glaucoma agudo o uveítis.
3. **El manejo inicial adecuado salva visión:** medir AV, evitar corticoides empíricos y derivar urgente.
4. **Quemaduras químicas** requieren irrigación inmediata y sostenida, sin esperar evaluación especializada.
5. **Pérdida visual indolora súbita** sugiere oclusión vascular o desprendimiento de retina.
6. **No se parchea el ojo en lesiones penetrantes ni úlceras.**
7. **Derivación temprana y documentación de AV inicial** son pilares clínico-legales y terapéuticos.